



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN PELAYANAN BEDAH 2025

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
NOMOR 713.4/I-PDM/IKO/VIII/2025

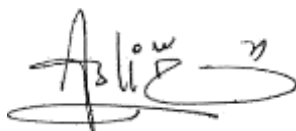
Tentang
Pedoman Pelayanan Bedah

Disusun oleh :
Kepala Pelayanan Anestesi



(dr. Arif Heru Wicaksono, Sp. An.)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Bedah dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada Malang.

Pedoman Pelayanan Bedah yang mulai dipergunakan pada tahun 2022 dan direvisi pada tahun 2025 ini meliputi tata laksana bedah. Mulai dari rencana asuhan, pembuatan laporan operasi, pelaksanaan *Surgical Safety Checklist*, pembuatan rencana asuhan pasca operasi, penggunaan implant, management pre operatif, manajemen operatif, manajemen post operatif, prinsip pelayanan bedah, serta dokumentasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Bedah ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada Malang dapat lebih baik.

Malang, 4 Agustus 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PELAYANAN BEDAH

1. dr. Nur Mazidah
2. Puput Sekar Nariratih, Amd. Keb.
3. dr. Arif Heru Wicaksono, Sp. An.
4. Siti Durotul Ibadiyah, S. Kep., Ns
5. Anita Sari, S. Kep., Ns.
6. Afni Pandyagaleni, S.Kep., Ns.
7. Yurike Devita, S. Kep., Ns.
8. Eko Pambudi, Amd. Kep.
9. Agus Hendra, S. Kep., Ns.
10. Ferry Kuswantoro, S. Kep., Ns.

DAFTAR ISI

SAMPUL

PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... i

TIM PENYUSUN..... ii

DAFTAR ISI..... iii

PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Tujuan dan Fungsi Pedoman Pelayanan Bedah 1

 1.3 Manfaat 1

BAB II RENCANA ASUHAN BERDASARKAN HASIL ASESMEN3

BAB III KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN OPERASI5

BAB IV PELAKSANAAN *SURGICAL SAFETY CHECKLIST*6

BAB V PEMBUATAN RENCANA ASUHAN PASCA OPERASI7

BAB VI PENGGUNAAN IMPLANT8

BAB VII MANAJEMEN PRE OPERATIF13

BAB VIII MANAJEMEN OPERATIF18

BAB IX MANAJEMEN POST OPERATIF20

BAB X PRINSIP PELAYANAN BEDAH23

BAB XI DOKUMENTASI28

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 713.4/I-PDM/IKO/VIII/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN BEDAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada maka diperlukan adanya kebijakan pelayanan Instalasi Kamar Operasi yang optimal;
 - b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 972/I-PDM/DIR/XII/2021 tentang Pedoman Pelayanan Bedah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Bedah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
 9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN BEDAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Pelayanan bedah adalah pelayanan medis kepada pasien dalam tindakan operasi.
- (3) Profesional Pemberi Asuhan (PPA) adalah staf klinis profesional yang langsung memberikan asuhan kepada pasien, misalnya staf medis, keperawatan, farmasi, gizi, staf psikologi klinis, dll, dan memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (4) Asuhan Keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan dalam praktik keperawatan langsung pada pasien/klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya didasarkan pada kaidah profesi keperawatan dan merupakan inti praktik keperawatan.
- (5) Informasi, Analisis, Rencana (IAR) adalah sistematika proses melakukan Pengkajian pasien.
- (6) Rekam medis adalah bukti tertulis (kertas / elektronik) yang merekam berbagai informasi kesehatan pasien seperti temuan hasil Pengkajian, rencana asuhan, rincian pelaksanaan asuhan dan pengobatan, catatan perkembangan pasien terintegrasi, serta ringkasan kepulangan pasien yang dibuat oleh profesional pemberi asuhan (PPA).
- (7) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya.
- (8) Implant adalah salah satu alat kesehatan yang tidak mengandung obat, digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

BAB II

PENGKAJIAN PRABEDAH

Pasal 2

- (1) Asuhan setiap pasien bedah direncanakan berdasar atas hasil pengkajian dan dicatat dalam rekam medis pasien.
- (2) Pengkajian prabedah pada pasien yang akan dioperasi dilakukan oleh DPJP sebelum operasi dimulai.



- (3) Hasil pengkajian prabedah memberikan informasi tentang :
 - a. Tindakan bedah yang sesuai dan waktu pelaksanaannya;
 - b. Melakukan tindakan dengan aman; dan
 - c. Menyimpulkan temuan selama pemantauan.
- (4) Pemilihan teknik operasi bergantung pada riwayat pasien, status fisik, data diagnostik, serta manfaat dan risiko tindakan yang dipilih.
- (5) Pemilihan tindakan mempertimbangkan pengkajian waktu pasien masuk dirawat inap, pemeriksaan diagnostik, dan sumber lainnya.
- (6) Proses pengkajian dikerjakan segera pada pasien darurat.

Pasal 3

- (1) Pasien yang saat masuk rumah sakit langsung dilayani oleh dokter bedah, pengkajian pra bedah menggunakan formulir Pengkajian awal rawat inap.
- (2) Pasien yang dikonsultasikan di tengah perawatan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) lain dan diputuskan operasi maka pengkajian pra bedah dapat dicatat di rekam medis (dengan isi berbasis IAR) sesuai dengan regulasi rumah sakit.
- (3) Pengkajian prabedah pada pasien yang akan operasi digunakan untuk menentukan rencana operasi dicatat oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) di rekam medis pasien sebelum operasi dimulai.
- (4) Diagnosis praoperasi dan rencana prosedur/ tindakan operasi berdasarkan hasil pengkajian prabedah dan didokumentasikan di rekam medis.

BAB III

KOMUNIKASI DAN EDUKASI PELAYANAN BEDAH

Pasal 4

- (1) Pasien, keluarga, dan mereka yang memutuskan diberikan edukasi tentang risiko, manfaat, komplikasi dan dampak serta alternatif prosedur/ teknik terkait dengan rencana operasi.
- (2) Pasien, keluarga, dan mereka yang memutuskan diberikan edukasi tentang risiko, manfaat, komplikasi dan dampak serta alternatif prosedur/ teknik terkait dengan penggunaan darah dan produk darah.
- (3) Pemberian informasi dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) didokumentasikan dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran.

BAB IV

PELAKSANAAN *SURGICAL SAFETY CHECKLIST*

Pasal 5

Penerapan proses *Time Out* menggunakan *Surgical safety checklist* dari WHO terkini pada tindakan operasi termasuk tindakan medis invasif.

Pasal 6

Surgical safety checklist terdiri dari 3 tahapan:

1. *Sign In* dilakukan sesaat sebelum pasien diinduksi anestesi;
2. *Time Out* dilakukan sesaat sebelum pasien diincisi;
3. *Sign Out* dilakukan sebelum pasien meninggalkan ruang operasi.



BAB V LAPORAN OPERASI

Pasal 7

- (1) Informasi yang terkait dengan operasi dicatat dalam laporan operasi untuk menyusun rencana asuhan lanjutan.
- (2) Laporan operasi dicatat segera setelah operasi, sebelum dipindah dari area operasi atau area pemulihan pasca anestesi dengan meliputi:
 - a. Diagnosis pasca operasi;
 - b. Nama dokter bedah dan asistennya;
 - c. Prosedur operasi yang dilakukan dan rincian temuan;
 - d. Ada dan tidaknya komplikasi;
 - e. Spesimen operasi yang dikirim untuk diperiksa;
 - f. Jumlah darah yang hilang dan jumlah darah yang masuk lewat transfusi;
 - g. Nomor pendaftaran alat yang dipasang (implan), (bila menggunakan);
 - h. Tanggal, waktu dan tanda tangan dokter yang bertanggungjawab.
- (3) Waktu selesai membuat laporan didefinisikan sebagai setelah selesai operasi, sebelum pasien dipindah ke tempat asuhan biasa.
- (4) Laporan operasi dapat dicatat di area asuhan intensif lanjutan apabila dokter bedah mendampingi pasien dari ruang operasi ke ruangan intensif lanjutan (ICU).

BAB V RENCANA ASUHAN PASCA OPERASI

Pasal 8

- (1) Rencana asuhan pasca operasi dibuat oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat, dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya untuk memenuhi kebutuhan segera pasien pasca operasi.
- (2) Rencana asuhan pasca operasi dicatat di rekam medis pasien dalam waktu 24 jam oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP).
- (3) Pelaksanaan rencana asuhan pasca operasi termasuk rencana asuhan medis, keperawatan, dan PPA lainnya berdasar atas kebutuhan pasien.
- (4) Pelaksanaan rencana asuhan pasca operasi diubah berdasar atas asesmen ulang pasien.

BAB VI PENGUNAAN IMPLAN

Pasal 9

- (1) Asuhan pasien operasi yang menggunakan implan memperhatikan pertimbangan khusus tentang tindakan yang dimodifikasi seperti :
 - a. Pemilihan implan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Modifikasi *surgical safety checklist* untuk memastikan ketersediaan implan di kamar operasi dan pertimbangan khusus untuk penandaan lokasi operasi;
 - c. Kualifikasi dan pelatihan setiap staf dari luar yang dibutuhkan untuk pemasangan implan (staf dari pabrik/ perusahaan implant untuk mengkalibrasi);
 - d. Proses pelaporan jika ada kejadian yang tidak diharapkan terkait implan;
 - e. Proses pelaporan jika ada hal yang tidak diharapkan terkait implant;



- f. Pertimbangan pengendalian infeksi yang khusus;
 - g. Instruksi khusus kepada pasien setelah operasi;
 - h. Kemampuan penelusuran (*traceability*) alat jika ada penarikan kembali (*recall*) alat medis antara lain dengan menempelkan barcode alat di rekam medis.
- (2) Penggunaan implant harus sesuai dengan daftar alat implant yang ditetapkan di rumah sakit.
 - (3) Penempelan barcode alat di rekam medis memudahkan penelusuran (*traceability*) alat jika terjadi penarikan kembali (*recall*) alat implant.
 - (4) Proses untuk melacak pasien dalam jangka waktu yang ditentukan setelah menerima pemberitahuan adanya *recall* implant medis.
 - (5) Proses *traceability* rumah sakit meminta pasien melapor bila ada perubahan alamat/ no. kontak.

BAB VII

TINDAKAN BEDAH DILUAR KAMAR OPERASI

Pasal 10

Setiap tindakan bedah yang dilakukan diluar kamar operasi yang bertujuan untuk melukai atau menciderai bagian tubuh, kecuali pemasangan infus dan pengambilan darah wajib dilaporkan dan dimonitoring oleh staf yang berkompeten dan berwenang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelayanan Bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 972/I-PDM/DIR/XII/2021 tentang Pedoman Pelayanan Bedah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 4 Agustus 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR 713.3/I-PDM/IKO/VIII/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN BEDAH

PEDOMAN PELAYANAN BEDAH
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan anestesi, sedasi, dan intervensi bedah adalah proses yang umum dan kompleks di rumah sakit. Tindakan-tindakan ini membutuhkan asesmen pasien yang lengkap dan komprehensif, perencanaan asuhan yang terintegrasi, monitoring pasien yang berkesinambungan dan kriteria transfer untuk pelayanan berkelanjutan, rehabilitasi, akhirnya transfer maupun pemulangan (*discharge*).

Pelayanan bedah di Instalasi Kamar Operasi Rumah sakit Prima Husada harus terencana dan terdokumentasikan berdasarkan hasil asesmen. Karena tindakan pembedahan membawa risiko dengan tingkatan tinggi, maka penggunaannya haruslah direncanakan secara seksama. Asesmen pasien adalah dasar untuk memilih prosedur yang tepat. Asesmen memberikan informasi penting terhadap pemilihan prosedur yang tepat dan waktu yang optimal, terlaksananya prosedur secara yang aman, menginterpretasikan temuan dalam monitoring pasien. Pemilihan prosedur tergantung pada riwayat pasien, status fisik, dan data diagnostik termasuk risiko dan manfaat prosedur bagi pasien. Pemilihan prosedur mempertimbangkan informasi dari asesmen saat masuk rawat inap, tes diagnostik, dan sumber lain yang tersedia.

Proses asesmen dapat dijalankan dalam kerangka waktu yang lebih singkat bilamana pasien secara darurat membutuhkan pembedahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah edukasi dan diskusi dengan pasien dan keluarganya atau orang yang berwenang membuat keputusan bagi pasien. Pasien dan keluarga atau para pembuat keputusan menerima informasi yang adekuat untuk berpartisipasi dalam keputusan pemberian pelayanan dan memberikan persetujuan (*informed consent*) yang berisi risiko dari prosedur yang direncanakan, manfaat prosedur yang direncanakan, komplikasi yang potensial terjadi, alternatif tindakan pembedahan dan nonbedah yang tersedia untuk merawat.

1.2 Tujuan dan Fungsi Pedoman Pelayanan Bedah

1. Meningkatkan keamanan tindakan bedah dengan menciptakan standarisasi prosedur yang aman.
2. Mengurangi tingkat mortalitas, morbiditas, dan disabilitas / kecacatan akibat komplikasi prosedur bedah.
3. *Me-recall* memori, terutama pada hal-hal kecil yang gampang terabaikan pada keadaan pasien yang kompleks.

1.3 Manfaat

1. Terselenggaranya pelayanan bedah yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia.

-
2. Terselenggaranya kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur bedah dan etik profesi.
 3. Melindungi pasien dari risiko salah pasien, salah posisi dan salah prosedur operasi dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

BAB II

RENCANA ASUHAN BERDASARKAN HASIL ASESMEN

Asesmen pra bedah (berbasis IAR) menjadi acuan untuk menentukan jenis tindakan bedah yang tepat dan mencatat temuan penting. Karena prosedur bedah mengandung risiko tinggi maka pelaksanaannya harus direncanakan dengan saksama. Hasil asesmen memberikan informasi tentang:

1. tindakan bedah yang sesuai dan waktu pelaksanaannya;
2. melakukan tindakan dengan aman; dan
3. menyimpulkan temuan selama monitoring.

Pemilihan teknik operasi bergantung pada riwayat pasien, status fisik, data diagnostik, serta manfaat dan risiko tindakan yang dipilih. Pemilihan tindakan juga mempertimbangkan asesmen waktu pasien masuk dirawat inap, pemeriksaan diagnostik, dan sumber lainnya. Proses asesmen dikerjakan segera pada pasien darurat.

Asuhan untuk pasien bedah dicatat di rekam medis. Untuk pasien yang langsung dilayani oleh dokter bedah, asesmen pra bedah menggunakan asesmen awal rawat inap, pada pasien yang diputuskan dilakukan pembedahan dalam proses perawatan. Asesmen dicatat dalam rekam medis, sedangkan pasien yang dikonsultasikan di tengah perawatan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) lain dan diputuskan operasi maka asesmen pra bedah juga dicatat di rekam medis (dengan isi berbasis IAR) dengan menggunakan asesmen awal rawat inap. Hal ini termasuk diagnosis pra operasi dan pasca operasi serta nama tindakan operasi.

Proses asesmen pasien yang efektif akan menghasilkan keputusan mengenai kebutuhan penanganan pasien segera mungkin dan berkesinambungan. Kebutuhan ini mencakup keadaan gawat darurat, elektif atau untuk perawatan terencana, bahkan ketika kondisi pasien berubah.

Assesmen pasien terdiri atas tiga proses utama:

1. Pengumpulan informasi dan data mengenai status fisik, psikologis, dan sosial serta riwayat kesehatan pasien.
2. Analisa data dan informasi, termasuk hasil tes laboratorium dan pencitraan diagnostik (*imaging diagnostic*) untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan pasien.
3. Pengembangan rencana untuk memenuhi kebutuhan pasien yang telah diidentifikasi.

Beberapa poin penting dalam mengkaji faktor risiko pasien:

1. Alergi
2. Riwayat kesehatan sebelumnya (misalnya tekanan darah tinggi, asma, masalah jantung atau pernapasan)
3. Penggunaan tembakau (karena rokok meningkatkan risiko infeksi)
4. Penggunaan alkohol dan narkotika
5. Pengalaman pribadi pasien dengan sedasi dan anestesi sebelumnya
6. Berat badan
7. Obat-obatan yang dikonsumsi saat ini
8. Ada tidaknya risiko untuk anestesi dan sedasi
9. Permintaan khusus dari pasien untuk jenis anestesi dan sedasi
10. Kecemasan pasien
11. Delirium
12. Status nutrisi

13. Risiko potensial untuk *deep vein thrombosis*

Obat-obatan yang diberikan pada pasien harus dilabel dengan mencakup informasi seperti di bawah ini:

1. Nama
2. Kekuatan
3. Jumlah / konsentrasi
4. Tanggal kadaluwarsa
5. Pelarut dan volumenya
6. Tanggal diberikan

BAB III

KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN OPERASI

Asuhan pasien pasca operasi bergantung pada temuan dalam operasi. Hal yang terpenting adalah semua tindakan dan hasilnya dicatat di rekam medis pasien. Laporan ini dapat dibuat oleh dokter operator dalam bentuk format template atau dalam bentuk laporan operasi tertulis sesuai dengan regulasi rumah sakit. Untuk mendukung kesinambungan asuhan pasien pasca operasi maka laporan operasi dicatat segera setelah operasi selesai, sebelum pasien dipindah dari daerah operasi atau dari area pemulihan pasca anestesi. Laporan yang tercatat tentang operasi memuat paling sedikit

1. Diagnosis pasca operasi;
2. Nama dokter bedah dan asistennya;
3. Prosedur operasi yang dilakukan dan rincian temuan;
4. Ada dan tidak ada komplikasi;
5. Spesimen operasi yang dikirim untuk diperiksa;
6. Jumlah darah yang hilang dan jumlah yang masuk lewat transfusi;
7. Nomor pendaftaran alat yang dipasang (implan);
8. Tanggal, waktu, dan tanda tangan dokter yang bertanggung jawab.

Beberapa catatan mungkin ditempatkan di lembar lain dalam rekam medik. Contoh, jumlah darah yang hilang dan transfusi darah dicatat di catatan anestesi atau catatan tentang implan dapat ditunjukkan dengan “sticker” yang ditempelkan pada bagian penempelan kebutuhan operasi. Waktu selesai membuat laporan didefinisikan sebagai “setelah selesai operasi, sebelum pasien dipindah ke tempat asuhan biasa”. Definisi ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang tepat tersedia bagi pemberi asuhan berikutnya. Jika dokter bedah mendampingi pasien dari ruang operasi ke ruangan asuhan intensif lanjutan (misalnya ICU, ICCU, dsb.) maka laporan operasi dapat dibuat di daerah asuhan lanjutan. Perlu diperhatikan laporan operasi yang terlalu singkat dapat mengakhibatkan ketidakjelasan urutan prosedur, hal ini dapat menimbulkan permasalahan serius terutama bila terjadi pengajuan kasus pengadilan.

BAB IV

PELAKSANAAN *SURGICAL SAFETY CHECKLIST*

Pelaksanaan *Surgical Safety Checklist* dipimpin oleh perawat sirkular. Ada 3 periode terpenting dalam pelaksanaan *Surgical safety checklist* :

4.1 Sebelum induksi (*sign in*)

Langkah pertama yang dilakukan segera setelah pasien tiba di ruang serah terima sebelum dilakukan induksi anestesi. Tindakan yang dilakukan adalah memastikan identitas, lokasi/ area operasi, kesiapan mesin anestesi dan obat-obatan, *pulse oxymetri*, alergi pada pasien, risiko aspirasi, dan risiko kehilangan darah > 500cc atau 7ml/kg BB pada anak-anak, prosedur operasi serta persetujuan operasi. Pasien atau keluarga diminta secara lisan untuk menyebutkan nama lengkap, tanggal lahir dan tindakan yang akan dilakukan. Penandaan lokasi operasi harus sudah dilakukan oleh ahli bedah yang akan melakukan operasi. Alat dan Implant yang akan digunakan sudah dipastikan ada dan siap digunakan. Pemeriksaan keamanan anestesi oleh ahli anestesi dan harus memastikan kondisi pernapasan, risiko perdarahan, antisipasi adanya komplikasi, dan riwayat alergi pasien. Memastikan peralatan anestesi berfungsi dengan baik, ketersediaan alat, dan obat-obatan. Proses ini paling tidak harus dihadiri oleh perawat sirkuler dan dokter spesialis anestesi.

4.2 Sebelum Insisi (*time out*)

Merupakan langkah kedua yang dilakukan pada saat pasien sudah berada di ruang operasi, sesudah induksi anestesi dilakukan dan sebelum ahli bedah melakukan sayatan kulit. Untuk kasus pada satu pasien terdapat beberapa tindakan dengan beberapa ahli bedah *time out* dilakukan tiap kali pergantian operator. Tujuan dilakukan *time out* adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan pasien, lokasi dan prosedur pembedahan dan meningkatkan kerjasama antara anggota tim bedah, komunikasi diantara tim bedah dan meningkatkan keselamatan pasien selama pembedahan. Seluruh tim bedah memperkenalkan diri dengan menyebut nama dan peran masing-masing. Menegaskan lokasi dan prosedur pembedahan, dan mengantisipasi risiko. Dokter spesialis bedah menjelaskan kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi. Dokter spesialis anestesi menjelaskan hal khusus yang perlu diperhatikan. Tim perawat menjelaskan ketersediaan dan kesterilan alat. Memastikan profilaksis antibiotik dan obat-obatan pre medikasi sudah diberikan. Memastikan apakah hasil radiologi yang ada dan diperlukan sudah ditampilkan dan diverifikasi oleh 2 orang. Proses ini paling tidak harus dihadiri oleh perawat sirkuler, dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis bedah.

4.3 Sebelum Keluar Kamar Operasi (*sign out*)

Merupakan tahap akhir yang dilakukan saat penutupan luka operasi atau sesegera mungkin setelah penutupan luka sebelum pasien dikeluarkan dari kamar operasi. Pemimpin pelaksanaan *Surgical safety checklist* memastikan prosedur sesuai rencana, kesesuaian jumlah alat, kasa, jarum, dan memastikan pemberian etiket dengan benar pada bahan-bahan yang akan dilakukan pemeriksaan patologi. Mengkonfirmasi apakah ada masalah pada peralatan yang digunakan, dan apa saja yang harus diperhatikan untuk pemulihan dan manajemen pasien selama dalam masa pemulihan.

BAB V

PEMBUATAN RENCANA ASUHAN PASCA OPERASI

Kebutuhan asuhan medis, keperawatan, dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya sesuai dengan kebutuhan setiap pasien pasca operasi berbeda bergantung pada tindakan operasi dan riwayat kesehatan pasien. Beberapa pasien mungkin membutuhkan pelayanan dari profesional pemberi asuhan (PPA) lain atau unit lain seperti rehabilitasi medik atau terapi fisik. Penting membuat rencana asuhan tersebut termasuk tingkat asuhan, metode asuhan, tindak lanjut monitor atau tindak lanjut tindakan, kebutuhan obat, dan asuhan lain atau tindakan serta layanan lain. Rencana asuhan pasca operasi dapat dimulai sebelum tindakan operasi berdasarkan asesmen kebutuhan dan kondisi pasien serta jenis operasi yg dilakukan. Rencana asuhan pasca operasi juga memuat kebutuhan pasien yang segera. Rencana asuhan dicatat di rekam medik pasien dalam waktu 24 jam dan diverifikasi oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai pimpinan tim klinis untuk memastikan kontinuitas asuhan selama waktu pemulihan dan masa rehabilitasi. Kebutuhan pasca operasi dapat berubah sebagai hasil perbaikan klinis atau informasi baru dari asesmen ulang rutin, atau dari perubahan kondisi pasien yang mendadak. Rencana asuhan pascaoperasi direvisi berdasar atas perubahan ini dan dicatat di rekam medis pasien sebagai rencana asuhan baru.

BAB VI PENGUNAAN IMPLANT

6.1 Implant

Banyak tindakan bedah menggunakan implan prostetik antara lain panggul dan lutut. Tindakan operasi seperti ini mengharuskan tindakan operasi rutin yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan faktor khusus seperti:

1. Pemilihan implan berdasar atas peraturan perundangan;
 - a. Setiap pemilihan dan penggunaan implan di Instalasi Kamar Operasi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar pelayanan medis dan keselamatan pasien.
 - b. Implan yang digunakan wajib:
 - 1) Memiliki izin edar resmi dari instansi berwenang di bidang alat kesehatan;
 - 2) Terdaftar secara legal dan dapat ditelusuri (*traceable*);
 - 3) Memenuhi standar mutu, keamanan, dan manfaat;
 - 4) Berasal dari distributor atau penyedia resmi sesuai ketentuan pengadaan barang/ jasa.
 - c. Pemilihan jenis dan spesifikasi implan harus:
 - 1) Berdasarkan indikasi medis yang jelas dan berbasis *evidence-based medicine*;
 - 2) Sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinis (*clinical privilege*) dokter operator;
 - 3) Disesuaikan dengan klasifikasi, kemampuan fasilitas, serta sumber daya Rumah Sakit.
 - d. Sebelum tindakan operasi, pasien atau keluarga wajib diberikan penjelasan mengenai jenis implan, manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta kemungkinan komplikasi, dan wajib menandatangani persetujuan tindakan medis (*informed consent*).
 - e. Instalasi Kamar Operasi wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian penggunaan implan secara lengkap dalam rekam medis, termasuk nomor batch/ lot untuk keperluan penelusuran dan audit.
2. Modifikasi *surgical safety checklist* untuk memastikan ketersediaan implan di kamar operasi dan pertimbangan khusus untuk penandaan lokasi operasi; Pada saat sebelum operasi dicek ketersediaan alat tambahan dan implant yang akan digunakan dengan menggunakan daftar alat tambahan.
3. Pertimbangan pengendalian infeksi yang khusus;
4. Instruksi khusus kepada pasien setelah operasi mulai dari mobilisasi bertahap, diit pada pasien setelah operasi, meminta pasien jika ada pergantian nomor telepon dan alamat agar menginfokan ke pihak rumah sakit.
5. Kemampuan penelusuran (*traceability*) alat jika terjadi penarikan kembali (*recall*) alat dengan melakukan antara lain menempelkan barcode alat di rekam medis.
6. Pengadaan implant sesuai dengan standart mutu yang telah ditetapkan untuk menjamin kualitas implant tersebut.

6.2 Prosedur Penarikan Kembali (*Recall*) Implant

1. Penarikan produksi dari Produsen yaitu adanya surat resmi dari produsen tentang penarikan produk atau peralatan yang ada di rumah sakit.
2. Penarikan disebabkan karena kecacatan produksi, tidak lulus uji kalibrasi dan dikirim tidak sesuai spesifikasi alat. Jika ditemukan hal tersebut maka segera lakukan koordinasi dengan IFRS dan DPJP untuk dilakukan penarikan kembali.
3. Melakukan penarikan alat yang tersimpan didalam kamar operasi.
4. Jika alat yang dilakukan penarikan sedang digunakan pasien, maka lakukan telusur pada rekapan alat beserta nomer kode implan yang digunakan pada pasien, jika perlu lakukan penelusuran pada rekam medis.

5. Tulis dalam form penarikan alat, dan segera melapor ke direktur. Direktur akan membuat surat kepada distributor agar ditarik dan diganti dengan peralatan yang baru dan aman.

6.3 Daftar Implant

No.	Nama Implant	Ukuran	Jumlah
1	Broad DCP Plate	8 Hole	1
2	Broad DCP Plate	9 Hole	1
3	Broad DCP Plate	10 Hole	1
4	Broad DCP Plate	11 Hole	1
5	Broad DCP Plate	12 Hole	1
6	Broad DCP Plate	13 Hole	1
7	Broad DCP Plate	14 Hole	1
8	Narrow Plate	6 Hole	1
9	Narrow Plate	7 Hole	1
10	Narrow Plate	8 Hole	1
11	Narrow Plate	9 Hole	1
12	Narrow Plate	10 Hole	1
13	Narrow Plate	11 Hole	1
14	Narrow Plate	12 Hole	1
15	Narrow Plate	14 Hole	1
16	T-Plate	3 Hole	1
17	T-Plate	4 Hole	1
18	T-Plate	5 Hole	1
19	T-Plate	6 Hole	1
20	T-Plate	7 Hole	1
21	T-Plate	8 Hole	1
22	T-Plate	9 Hole	1
23	T-Plate	10 Hole	1
24	Throcanter Ear	4 Hole	1
25	Throcanter Ear	5 Hole	1
26	Throcanter Ear	6 Hole	1
27	Throcanter Ear	7 Hole	1
28	Throcanter Ear	8 Hole	1
29	Throcanter Ear	9 Hole	1
30	Throcanter Ear	10 Hole	1
31	Throcanter Ear	11 Hole	1
32	TLC-ACP	3 Hole R	1
33	TLC-ACP	3 Hole L	1
34	TLC-ACP	5 Hole R	1
35	TLC-ACP	5 Hole L	1
36	TLC-ACP	7 Hole R	1
37	TLC-ACP	7 Hole L	1
38	TLC-ACP	9 Hole R	1
39	TLC-ACP	9 Hole L	1
40	Condylar Buttress Plate	4 Hole R	1
41	Condylar Buttress Plate	5 Hole R	1
42	Condylar Buttress Plate	6 Hole R	1
43	Condylar Buttress Plate	7 Hole R	1
44	Condylar Buttress Plate	8 Hole R	1
45	Condylar Buttress Plate	9 Hole R	1
46	Condylar Buttress Plate	10 Hole R	1
47	Condylar Buttress Plate	11 Hole R	1

48	Condylar Buttress Plate	4 Hole L	1
49	Condylar Buttress Plate	5 Hole L	1
50	Condylar Buttress Plate	6 Hole L	1
51	Condylar Buttress Plate	7 Hole L	1
52	Condylar Buttress Plate	8 Hole L	1
53	Condylar Buttress Plate	9 Hole L	1
54	Condylar Buttress Plate	10 Hole L	1
55	Condylar Buttress Plate	11 Hole L	1
56	Small T-Plate	3 Hole	1
57	Small T-Plate	4 Hole	1
58	Small T-Plate	5 Hole	1
59	Small T-Plate	6 Hole	1
60	Small T-Plate	7 Hole	1
61	Small T-Plate	8 Hole	1
62	Small DCP	5 Hole	1
63	Small DCP	6 Hole	1
64	Small DCP	7 Hole	1
65	Small DCP	8 Hole	1
66	Small DCP	9 Hole	1
67	Small DCP	10 Hole	1
68	1/3 Tubular	5 Hole	1
69	1/3 Tubular	6 Hole	1
70	1/3 Tubular	7 Hole	1
71	1/3 Tubular	8 Hole	1
72	1/3 Tubular	9 Hole	1
73	1/3 Tubular	10 Hole	1
74	S-Plate	6 Hole R	1
75	S-Plate	6 Hole L	1
76	S-Plate	7 Hole R	1
77	S-Plate	7 Hole L	1
78	S-Plate	8 Hole R	1
79	S-Plate	8 Hole L	1
80	S-Plate	9 Hole R	1
81	S-Plate	9 Hole L	1
82	Hookplate Clavícula	3 Hole R	1
83	Hookplate Clavícula	3 Hole L	1
84	Hookplate Clavícula	4 Hole R	1
85	Hookplate Clavícula	4 Hole L	1
86	Hookplate Clavícula	5 Hole R	1
87	Hookplate Clavícula	5 Hole L	1
88	Hookplate Clavícula	6 Hole R	1
89	Hookplate Clavícula	6 Hole L	1
90	Humerus Proximal	3 Hole	1
91	Humerus Proximal	4 Hole	1
92	Humerus Proximal	5 Hole	1
93	Humerus Proximal	6 Hole	1
94	Humerus Proximal	7 Hole	1
95	Recontraction Plate (Straight)	3 Hole	1
96	Recontraction Plate (Straight)	4 Hole	1
97	Recontraction Plate (Straight)	5 Hole	1
98	Recontraction Plate (Straight)	6 Hole	1
99	Recontraction Plate (Straight)	7 Hole	1
100	Recontraction Plate (Straight)	8 Hole	1

101	Recontraction Plate (Curve)	4 Hole	1
102	Recontraction Plate (Curve)	5 Hole	1
103	Recontraction Plate (Curve)	6 Hole	1
104	Recontraction Plate (Curve)	7 Hole	1
105	Recontraction Plate (Curve)	8 Hole	1
106	Recontraction Plate (Curve)	9 Hole	1
107	Recontraction Plate (Curve)	10 Hole	1
108	Ring Washer	3,5 mm	2
109	Ring Washer	4,5 mm	2
110	Ring Washer	6,5 mm	2
111	K- Wire	0,8 mm	2
112	K- Wire	1,0 mm	2
113	K- Wire	1,2 mm	2
114	K- Wire	1,4 mm	2
115	K- Wire	1,6 mm	2
116	K- Wire	1,8 mm	2
117	K- Wire	2,0 mm	2
118	K- Wire	2,2 mm	1
119	K- Wire	2,5 mm	2
120	K- Wire	3,0 mm	2
121	S - Wire	0,8 mm	1
122	S - Wire	1,0 mm	1
123	S - Wire	1,2 mm	1
124	Steinman Pin	No. 130	2
125	Steinman Pin	No. 150	2
126	Steinman Pin	No. 180	2
127	Steinman Pin	No. 200	2
128	Screw Cortex 4,5 mm	No. 14	7
129	Screw Cortex 4,5 mm	No. 16	7
130	Screw Cortex 4,5 mm	No. 18	7
131	Screw Cortex 4,5 mm	No. 20	7
132	Screw Cortex 4,5 mm	No. 22	7
133	Screw Cortex 4,5 mm	No. 24	7
134	Screw Cortex 4,5 mm	No. 26	7
135	Screw Cortex 4,5 mm	No. 28	7
136	Screw Cortex 4,5 mm	No. 30	7
137	Screw Cortex 4,5 mm	No. 32	7
138	Screw Cortex 4,5 mm	No. 34	7
139	Screw Cortex 4,5 mm	No. 36	7
140	Screw Cortex 4,5 mm	No. 38	7
141	Screw Cortex 4,5 mm	No. 40	7
142	Screw Cortex 4,5 mm	No. 42	7
143	Screw Cortex 4,5 mm	No. 44	7
144	Screw Cortex 4,5 mm	No. 46	7
145	Screw Cortex 4,5 mm	No. 48	7
146	Screw Cortex 4,5 mm	No. 50	7
147	Screw Cortex 4,5 mm	No. 52	7
148	Screw Cancellous 6,5 mm Full	No. 45	2
149	Screw Cancellous 6,5 mm Full	No. 50	2
150	Screw Cancellous 6,5 mm Full	No. 55	2
151	Screw Cancellous 6,5 mm Full	No. 60	2
152	Screw Cancellous 6,5 mm Full	No. 65	2
153	Screw Cancellous 6,5 mm Full	No. 70	2

154	Screw Cancellous 6,5 mm Full	No. 75	2
155	Screw Cancellous 6,5 mm Full	No. 80	2
156	Screw Cancellous 6,5 mm Full	No. 85	2
157	Screw Cancellous 6,5 mm Full	No. 90	2
158	Screw Cancellous 6,5 mm ½ Thrid	No. 45	2
159	Screw Cancellous 6,5 mm ½ Thrid	No. 50	2
160	Screw Cancellous 6,5 mm ½ Thrid	No. 55	2
161	Screw Cancellous 6,5 mm ½ Thrid	No. 60	2
162	Screw Cancellous 6,5 mm ½ Thrid	No. 65	2
163	Screw Cancellous 6,5 mm ½ Thrid	No. 70	2
164	Screw Cancellous 6,5 mm ½ Thrid	No. 75	2
165	Screw Cancellous 6,5 mm ½ Thrid	No. 80	2
166	Screw Cancellous 6,5 mm ½ Thrid	No. 85	2
167	Screw Cancellous 6,5 mm ½ Thrid	No. 90	2
168	Screw Maleolar 4,5 mm	No. 25	2
169	Screw Maleolar 4,5 mm	No. 30	2
170	Screw Maleolar 4,5 mm	No. 35	2
171	Screw Maleolar 4,5 mm	No. 40	2
172	Screw Maleolar 4,5 mm	No. 45	2
173	Screw Maleolar 4,5 mm	No. 50	2
174	Schanz Screw	No. 130	6
175	Schanz Screw	No. 150	6
176	Schanz Screw	No. 180	6
177	Screw Cortex 3,5 mm	No. 12	9
178	Screw Cortex 3,5 mm	No. 14	9
179	Screw Cortex 3,5 mm	No. 16	9
180	Screw Cortex 3,5 mm	No. 18	9
181	Screw Cortex 3,5 mm	No. 20	9
182	Screw Cortex 3,5 mm	No. 22	9
183	Screw Cortex 3,5 mm	No. 24	9
184	Screw Cortex 3,5 mm	No. 26	9
185	Screw Cortex 3,5 mm	No. 28	9
186	Screw Cortex 3,5 mm	No. 30	9
187	Screw Cortex 3,5 mm	No. 32	9
188	Screw Cancellous 4,0 mm	No. 14	5
189	Screw Cancellous 4,0 mm	No. 16	5
190	Screw Cancellous 4,0 mm	No. 18	5
191	Screw Cancellous 4,0 mm	No. 20	5
192	Screw Cancellous 4,0 mm	No. 22	5
193	Screw Cancellous 4,0 mm	No. 24	5
194	Screw Cancellous 4,0 mm	No. 26	5
195	Screw Cancellous 4,0 mm	No. 28	5
196	Screw Cancellous 4,0 mm	No. 30	5
197	Screw Cancellous 4,0 mm	No. 32	5
198	Screw Cancellous 4,0 mm	No. 34	5
199	Screw Maleolar 4,0 mm	No. 14	5
200	Screw Maleolar 4,0 mm	No. 16	5
201	Screw Maleolar 4,0 mm	No. 18	5
202	Screw Maleolar 4,0 mm	No. 20	5
203	Screw Maleolar 4,0 mm	No. 22	5
204	Screw Maleolar 4,0 mm	No. 24	5
205	Screw Maleolar 4,0 mm	No. 26	5
206	Screw Maleolar 4,0 mm	No. 28	5

207	Screw Maleolar 4,0 mm	No. 30	5
208	Screw Maleolar 4,0 mm	No. 32	5
208	Screw Maleolar 4,0 mm	No. 34	5
209	Titanium Mini Plate with Stem	4 Hole	1
210	Titanium Mini Plate with Stem	6 Hole	1
211	Titanium Mini Plate	4 Hole	1
212	Titanium Mini Plate	5 Hole	1
213	Titanium Mini Plate	6 Hole	1
214	Titanium Mini Plate	7 Hole	1
215	Titanium Mini Plate	8 Hole	1
216	Titanium Mini Plate	9 Hole	1
217	Titanium Mini Plate	10 Hole	1
218	Titanium Mini Plate	11 Hole	1
219	Titanium Mini Plate	12 Hole	1
220	Titanium Mini Plate	13 Hole	1
221	Titanium Mini Plate	14 Hole	1
222	Titanium Mini Plate	15 Hole	1
223	Titanium Mini Plate	16 Hole	1
224	Titanium Mini Screw 2,0 mm	No. 7	20
225	Titanium Mini Screw 2,0 mm	N0. 9	20
226	Archbar	All Size	2
227	S-Wire	0,4	2

BAB VII MANAJEMEN PRE OPERATIF

7.1 Manajemen Kamar Operasi / Tempat Tindakan.

A. Tujuan

Manajemen kamar operasi atau tempat tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan penanganan pasien, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan kepuasan tim bedah yang mencakup di dalamnya dokter bedah, dokter anestesi, dan perawat.

Mengatur *block time* secara efektif. Pengaturan ini dibuat dalam bentuk penyusunan jadwal setiap harinya bahwa pada periode waktu tertentu telah disiapkan kamar operasi atau ruang tindakan. Dalam periode waktu itu seorang dokter bedah dapat melakukan operasi elektif atau emergensi, operasi singkat maupun prosedur tindakan yang memakan waktu lama. Bila tim bedah tidak memenuhi jadwal tersebut, maka mereka akan kehilangan kesempatan penggunaannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun *block time*:

1. Tetapkan peraturan yang jelas dan adil
2. *Block time* direview secara berkala setiap bulannya
3. Menambah sebuah kamar operasi yang diperuntukkan untuk kejadian *urgent*
4. Buat aturan yang jelas mengenai pembatalan sebelum waktu operasi yang sudah dijadwalkan (hal ini dapat berbeda disesuaikan dengan jenis operasi)

B. Durasi operasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Emergency*: prosedur yang mengancam nyawa atau tungkai dan harus selesai dikerjakan dalam 30 menit.
2. Prioritas: prosedur yang harus dikerjakan dalam 30 menit sampai 4 jam
3. *Urgent*: prosedur yang harus dikerjakan dalam 4 jam sampai 24 jam
4. *Non-urgent*: prosedur yang bisa dikerjakan setelah 24 jam.

Dalam kaitannya dengan kamar operasi yang diperuntukkan untuk kejadian *urgent*, hanya kasus emergensi, prioritas, dan *urgent* yang diperkenankan menggunakan kamar tersebut. Untuk itu, petugas penjadwalan kamar operasi perlu dibekali pengetahuan khusus / pelatihan mengenai hal ini.

C. Mengatur Penjadwalan secara Efektif.

1. Jadwal sedapat mungkin diatur agar tidak penuh di awal minggu dan kosong di hari-hari berikutnya. Pemulangan pasien-pasien *post operative* dikoordinasikan dengan dokternya agar tidak selalu menunggu waktu *visite* dokter. Hal ini dimaksudkan untuk mengefisienkan waktu perawatan pasien dan ranjang pasien tersebut dapat segera dialokasikan untuk pasien lain yang membutuhkan.
2. Dalam hal terjadi banyak kasus *urgent* dalam waktu yang bersamaan, pasien diprioritaskan berdasarkan kegawatdaruratannya dan dipertimbangkan berdasarkan masing-masing keilmuan. Ada empat prinsip dalam menyusun prioritas pasien untuk kamar operasi, yaitu: keselamatan pasien, akses dokter bedah dan pasien ke tempat tindakan, memaksimalkan efisiensi kamar bedah, dan meminimalkan waktu tunggu pasien. Ada beberapa cara untuk memaksimalkan jadwal kamar operasi, antaralain:
 - a. Menggunakan proses paralel, misalnya induksi anestesi dapat mulai dilakukan di kamar lain sementara menunggu proses pemindahan pasien sebelumnya ke ruang pemulihan.
 - b. Menggunakan klinik pre operatif untuk memastikan pasien siap menjalani operasi.
 - c. Kerjasama yang baik dalam tim bedah.
 - d. Memanfaatkan teknologi untuk menangani proses, misalnya *tracking infrared*, telepon seluler, *whiteboard* elektronik, dan lain-lain.
 - e. *On-time* dalam memulai operasi.

D. Memonitor Performa Kamar Operasi / Ruang Tindakan.

Sebelum prosedur dimulai, harus dilakukan persiapan ruangan. Hal ini meliputi menciptakan lapangan steril, menyiapkan alat-alat, dan memeriksa kelengkapannya.

- a. Penciptaan lapangan steril:
 - a. menempatkan duk steril di sekeliling situs operasi dan pada tempat alat-alat.
 - b. Semua personel harus mengenakan pakaian steril.
 - c. Hanya alat steril dan orang-orang yang telah steril yang diperbolehkan memasuki lapangan steril.
 - d. Jangan menempatkan alat-alat steril di dekat pintu yang terbuka.
 - e. Letakkan alat steril hanya pada lapangan steril.
 - f. Pastikan tangan telah *discrub* sebelum menyentuh alat steril.
 - g. Orang yang telah steril tidak diperkenankan menyentuh alat-alat tidak steril atau pergi ke tempat yang tidak steril.
 - h. Perlu diingat bahwa ujung kemasan dari alat-alat steril adalah tidak steril.
 - i. Perlu diingat bahwa sekali batas steril telah dilewati, hal ini telah dianggap terkontaminasi.
 - j. Jika ada keraguan tentang status sterilitas sesuatu alat atau area, harus dianggap telah terkontaminasi.
- b. Persiapan alat:

Ada empat tahap proses persiapan alat, yaitu: pencucian dan dekontaminasi, desinfeksi, sterilisasi, dan penyimpanan atau pemindahan ke lapangan steril. Ada beberapa jenis sterilisasi, yaitu menggunakan *steam*, *ethyleneoxide*, *ozone*, dan gas plasma.
- c. Persiapan perlengkapan anestesi.
- d. Memastikan kualitas udara dan ventilasi:
 - a. Ventilasi kamar operasi harus *positive-pressure*.
 - b. Udara harus masuk ke ruangan melalui ventilasi langit-langit yang tinggi dan keluar dari ruangan melalui *exhaust air outlet* dekat lantai yang berseberangan dengan ventilasi masuk.
 - c. Mengatur agar sedikitnya terjadi 15 kali pertukaran udara perjamnya, di mana 3 di antaranya harus udara segar.
 - d. Penyaringan udara yang diresirkulasi dan udara segar melalui filter yang baik dengan efisiensi minimum 90%.
 - e. Ruangan hanya diijinkan dibuka untuk perpindahan alat, personel tim bedah, dan pasien; selebihnya pintu dijaga agar selalu tertutup.
- e. Mengatur lalu-lintas:

Zona dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. *Unrestricted zone*: hanya orang-orang yang berkepentingan yang boleh berada di zona ini, tetapi baju luar bisa diperbolehkan.
- b. *Semirestricted zone*: zona ini adalah area yang terhubung dengan kamar operasi (contohnya: lorong, kantor, kamar alat), orang-orang yang berada di sini harus mengenakan pakaian *scrub* dengan lengan panjang, penutup rambut, dan sepatu bersih atau penutup sepatu.
- c. *Restricted zone*: zona ini terdiri dari kamar operasi dan area cuci tangan, orang-orang yang memasuki zona ini harus mengenakan kostum bedah lengkap termasuk masker. Mereka yang tidak *discrub* harus mengenakan jaket berlengan panjang lengkap dengan kancing tertutup. Masker khususnya harus dikenakan di ruangan dengan peralatan steril yang terbuka.

"Pastikan bahwa semua alat-alat yang diperlukan telah siap tersedia di dalam kamar operasi sebelum prosedur dimulai untuk meminimalkan lalu lintas yang tidak perlu dari dan ke dalam ruangan.

7.2 Manajemen pasien

Beberapa poin penting dalam mengkaji faktor risiko pasien:

1. Alergi
2. Riwayat kesehatan sebelumnya (misalnya tekanan darah tinggi, asma, masalah jantung atau pernapasan)
3. Penggunaan tembakau (karena rokok meningkatkan risiko infeksi), alkohol dan narkotika.
4. Pengalaman pribadi pasien dengan sedasi dan anestesi sebelumnya
5. Berat badan dan status nutris
6. Obat-obatan yang dikonsumsi saat ini
7. Ada tidaknya risiko untuk anestesi dan sedasi
8. Permintaan khusus dari pasien untuk jenis anestesi dan sedasi
9. Kecemasan pasien
10. Delirium
11. Risiko potensial untuk *deep vein thrombosis*, obat-obatan yang diberikan pada pasien harus dilabel dengan mencakup informasi seperti di bawah ini:
 - a. Nama
 - b. Kekuatan
 - c. Jumlah / konsentrasi
 - d. Tanggal kadaluwarsa
 - e. Pelarut dan volumenya
 - f. Tanggal diberikan
12. Penggunaan antibiotik profilaksis sesuai dengan kebijakan rumah sakit.

7.3 Manajemen Tim Bedah

A. Rekomendasi standar:

1. Kostum bedah harus terbuat dari bahan yang ringan dan karena kapas mudah terbakar dan memiliki banyak pori yang bisa dilewati mikro organisme.
2. Sepatu proteksi harus tertutup bagian depannya, bertumit rendah, bersol anti selip, dan dibersihkan secara berkala.
3. Sebelum memegang kostum bedah atau memasuki tempat kostum bedah, semua personel harus mencuci tangan dengan sabun dan air, antiseptik dan air, atau *antiseptic hand rub*.
4. Kostum bedah harus diganti setiap harinya atau setiap kali terkontaminasi atau basah. Bila kostum terdiri dari 2 bagian, atasan harus selalu dimasukkan ke dalam bawahan dan ukuran harus pas.
5. Semua personel harus menutupi kepala dan rambut muka.
6. Dalam kasus-kasus tertentu yang berisiko terciprat (misalnya kasus trauma), tim bedah harus mengenakan alat-alat proteksi tambahan.
7. Masker harus menutupi seluruh bagian mulut dan hidung.
8. Kostum bedah harus di *laundry* di fasilitas *laundry* yang terakreditasi.
9. Seluruh personel harus menerima edukasi dan pengarahan perihal kostum bedah ini.

B. Beberapa prinsip penggunaan sarung tangan:

1. Sarung tangan harus menjadi *barrier* yang efektif terhadap material infeksius, termasuk darah dan cairan tubuh.
2. Sarung tangan harus diganti setiap habis kontak dengan pasien atau setiap sarung tangan tersebut rusak.
3. Sarung tangan tidak boleh dicuci atau di *reuse*.
4. Untuk prosedur invasif, tenaga kesehatan harus memakai dua lapis sarung tangan, satu di atas yang lain.

C. *Wrong Site, Wrong Procedure, Wrong Person Surgery*.

1. Beberapa hal yang berpotensi untuk menimbulkan kekeliruan untuk *wrong surgery*:
 - a. Lebih dari satu dokter bedah terlibat
 - b. Dilakukan lebih dari satu prosedur.

-
- c. Pasien memiliki beberapa karakteristik khusus, seperti deformitas fisik atau obesitas massif.
 - d. Ada beberapa pasien yang memiliki nama yang sama atau prosedur yang sama atau di waktu yang bersamaan.
2. Tiga komponen penting protokol, yaitu:
 - a. Proses verifikasi
 - b. Menandai lokasi yang akan dilakukan operasi
 - c. *Time out*
 3. Beberapa prosedur yang tidak memerlukan penandaan:
 - a. Kasus organ tunggal (misalnya operasi jantung, operasi *caesar*)
 - b. Kasus intervensi seperti kateter jantung
 - c. Kasus yang melibatkan gigi
 - d. Prosedur yang melibatkan bayi prematur di mana penandaan akan menyebabkan tato permanen.

Dalam kasus-kasus di mana tidak dilakukan penandaan, alasan harus dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan. Sedapat mungkin penandaan melibatkan pasien untuk menghindarkan kekeliruan. Meskipun jarang, pasien boleh menolak penandaan setelah dijelaskan maksud dan tujuannya. Penandaan harus dibuat menggunakan *surgical marking pen* yang tidak hilang bila dicuci saat preparasi lapangan operasi. Untuk pasien dengan warna kulit gelap, boleh digunakan warna selain hitam atau biru gelap (birutua) agar penandaan jelas terlihat, misalnya warna merah. Pada kasus kasus seperti operasi spinal, dapat dilakukan proses dua tahap yang meliputi penandaan pre operatif per level spinal (yang akan dioperasi) dan *interspace* spesifik intraoperatif menggunakan *radiographic marking*. Jika terdapat beberapa prosedur dalam satu operasi, maka *time-out* harus dilakukan sebelum setiap prosedur. Apabila terjadi diskrepansi, prosedur tidak boleh dimulai sebelum tercapai kata sepakat oleh semua anggota tim (dalam *time-out*) atau sebelum semua pertanyaan atau masalah terjawab. *Time-out* ini harus terdokumentasikan, minimal berbentuk suatu pernyataan bahwa *time-out* telah dilakukan dan tercapai kata sepakat.

BAB VIII MANAJEMEN OPERATIF

8.1 Manajemen Intraoperatif

A. Monitoring Pasien Anestesi dan Sedasi

1. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh tim bedah:
 - a. Mengkomunikasikan risiko sebelum memulai prosedur
 - b. Memastikan kompetensi yang meliputi: memasukkan obat sesuai level anestesi yang diminta, memonitor pasien untuk mempertahankan level anestesi, memberhentikan anestesi dan menyelamatkan pasien jika mereka masuk 'terlalu dalam'
 - c. Menyiapkan obat-obatan emergensi dan antidotum
 - d. Mempersiapkan efek-efek samping obat (*medication error*)
 - e. Memantau tanda-tanda vital (tekanan darah, frekuensi denyut jantung dan ritme, frekuensi pernapasan, saturasi oksigen, akses intravena yang adekuat, nyeri)
 - f. Mempertimbangkan pemanfaatan teknologi untuk teknik anestesi
 - g. menggunakan mnemonic:
 - 1) *C* irculation, *capnograph*, *color* (saturasi)
 - 2) O ksigen
 - 3) V entilasi dan vaporisasi
 - 4) E ndotracheal tube
 - 5) R eview monitor dan peralatan
 - 6) *A* irway
 - 7) *B* reathing
 - 8) *C* irculation
 - 9) *D* rugs
 - 10) *A* wareness
 - 11) *S* wift check (pasien, dokter bedah, proses, dan respons)
2. *Awareness* anestesi: kasus-kasus di mana pasien bangun di tengah tengah anestesi (intraoperatif)
 - a. Mengidentifikasi pasien-pasien berisiko
 - b. Perawatan peralatan
 - c. Monitoring pasien

B. Memasukkan Obat

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko:
 - a. Mengidentifikasi pasien dan mengkonfirmasi alergi obat yang dimiliki
 - b. Memverifikasi obat sebelum pemberian obat
 - c. Menggunakan perintah verbal terstruktur
 - d. Mengidentifikasi penggunaan obat-obatan *high-alert*, menstandarisasi preparasi obat-obat yang dilarutkan agar siap digunakan
 - e. Menghindari pelarutan obat di lapangan operasi, pelarutan obat obat sebisa mungkin digunakan oleh apoteker terdaftar
 - f. Menggunakan hanya larutan *premixed*
 - g. Klinisi di ruang operasi harus mengkomunikasikan semua dosis
 - h. Obat yang akan dimasukkan dan mengklarifikasi dosis maksimal dengan dokter anestesi dan dokter bedah.
 - i. Mengedukasi perawat dan anggota lain yang bekerja di ruang operasi tentang penanganan dan pemberian obat-obat *high alert*
 - j. Mengkaji dan memvalidasi kompetensi klinis tentang penggunaan dan pemberian obat-obat *high alert*
2. Hal-hal lain yang perlu dimonitor secara ketat selama operasi:
 - a. Kadar glukosa
 - b. Suhu tubuh

-
- c. Penggunaan darah.
- C. Menghindari Masalah dalam Ruang Operasi
1. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari masalah dalam ruang operasi:
 - a. Meminimalkan *distraction* dan interupsi
 - b. Mencegah trauma benda tajam :
 - 1) keselamatan alat (skalpel yang terlindung, jarum berujung tumpul, dll)
 - 2) keselamatan teknik :
 - a) Menggunakan zona netral di mana benda-benda tajam ditempatkan tanpa kontak tangan
 - b) Menggunakan teknik tanpa sentuh
 - c) Menggunakan sarung tangan dua rangkap
 - d) Mempertimbangkan penggunaan sarung tangan anti-robek
 - e) Mengganti sarung tangan bedah secara rutin
 - f) Menggunakan teknik jahit yang mencegah trauma
 - g) Sebisa mungkin menghindari lapangan bedah ketika dokter bedah memotong dan menjahit memakai alas kaki yang terlindung
 - h) Program kontrol pajanan
 - i) Program edukasi
 - 3) Mencegah tertinggalnya benda-benda di dalam luka operasi dengan metode penghitungan alat-alat.
 - 4) Menangani spesimen secara benar (meliputi kontainer dan alat pengambilan spesimen, identifikasi spesimen, labeling, transportasi spesimen, komunikasi, pembuangan spesimen).
 - 5) Mencegah kebakaran:
 - (1) Persiapan pasien
 - (2) Penggunaan alat-alat secara aman
 - (3) Persiapan alat-alat
 - (4) Membatasi bahan-bahan yang mudah terbakar
 - (5) Mengontrol oksigen
 - (6) Membagi tugas di antara anggota tim bedah mengenai pencegahan kebakaran
 - (7) Komunikasi efektif dan kerja tim
 - 6) Merespons bila terjadi kebakaran:
 - (1) Bagaimana memadamkan api secepatnya
 - (2) Bagaimana menangani pasien bagaimana memindahkan pasien secara aman
 - (3) Bagaimana evakuasi ruang operasi secara aman
 - (4) Bagaimana mengaktifasi sistem keamanan kebakaran
 - (5) Bagaimana mencegah penyebaran asap
 - (6) Bagaimana menemukan dan menggunakan alat pemadam kebakaran
 - (7) Bagaimana peran tim pemadam kebakaran dari luar

BAB IX MANAJEMEN POST OPERATIF

9.1 Membersihkan Lingkungan Operasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pembersihan lingkungan operasi:

- A. Pembuangan sisa-sisa bekas operasi
 1. Sisa patologi manusia yang meliputi jaringan, organ, bagian tubuh, dan cairan
 2. Darah manusia dan komponen darah yang meliputi serum, plasma, dan komponen darah
 3. Benda tajam
 4. Sisa-sisa alat atau benda yang terkontaminasi pasien
 5. Benda-benda tajam yang tidak terpakai.
- B. Ketika menangani sisa-sisa bekas operasi, petugas yang bertugas mengumpulkan termasuk petugas kebersihan harus memakai alat pelindung diri untuk mencegah pajanan. Setelah sisa-sisa tersebut terkumpul, harus ditranspor ke area penyimpanan yang sesuai. Selama transpor harus diperhatikan bahwa benda terkontaminasi tidak kontak dengan alat steril. Untuk mencegah penyebaran infeksi, kereta pembawanya harus dibersihkan dan didesinfeksi sesuai jadwal.
- C. Transportasi *laundry* terkontaminasi. Sebelum membersihkan ruangan, linen kotor harus diangkat terlebih dahulu. Tekstil, linen, dan kain terkontaminasi harus dipindahkan dengan kontak seminimal mungkin dengan udara, permukaan, dan personel dalam ruangan. Sebelum memindahkan *laundry* dari permukaan, harus dipastikan benda tajam dan barang *nonlaundry* lainnya telah dipisahkan untuk memastikan keamanan transportasi dan trauma benda tajam. Dalam melipat linen, pastikan bagian terkontaminasi berada di tengah sehingga bagian yang bersih berperan sebagai *barrier* terhadap bagian yang kotor. *Laundry* terkontaminasi ditempatkan di kontainer berwarna merah atau yang bertanda *biohazard*. *Laundry* yang basah harus ditempatkan di kantong-kantong yang antibocor. Dalam transportasi, personel *laundry* tidak boleh memegang kantong berisi *laundry* terkontaminasi dengan tangan atau tubuhnya atau meremas kantongnya untuk mencegah tertusuk jarum atau benda tajam lain yang tanpa sengaja tertinggal.
- D. Membersihkan Area Operasi
 1. Kamar operasi minimal harus dibersihkan setiap 24 jam bila tidak ada kegiatan atau ruangan tidak dipakai.
 2. Bila area terkontaminasi, maka kontaminasi harus dibersihkan / diangkat terlebih dahulu baru area dibersihkan dengan desinfektan karena banyak kontaminan menginaktivasi desinfektan
 3. Bila kontaminasi basah, luas, dan infeksius, maka harus diletakkan kain yang bisa menyerap cairan dan desinfektan dituang ke atas kain tersebut sampai semuanya basah terendam. Dapat juga digunakan bubuk penyerap yang memadatkan cairan.
 4. Bahan desinfektan terhadap darah dan cairan tubuh yang direkomendasikan adalah yang efektif terhadap virus hepatitis B dan HIV, tuberkulosis, dan yang cocok untuk segala jenis permukaan, misalnya berpori maupun non-pori.
 5. Debu harus ditangani dengan menggunakan kain khusus debu atau alat pel yang mencegah terbangnya debu. Untuk area yang lebih tinggi dari bahu, petugas kebersihan harus menggunakan alat yang khusus didesain untuk permukaan tinggi. Alat pembersih debu tidak boleh digoyang-goyangkan karena spora jamur bisa beterbangan di udara.

6. Untuk menghindari terpeleset atau tersandung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan :
 - a. Area yang licin harus ditutup untuk sementara untuk semua karyawan, kecuali petugas kebersihan
 - b. Tutup pintu dan tempatkan tanda dilarang masuk
 - c. Mulai dari area yang paling bersih ke daerah yang paling kotor.
 - d. Gunakan wax atau alas bergerigi untuk menciptakan permukaan anti slip
 - e. Pindahkan penghalang atau tanda-tanda dilarang masuk hanya setelah lantai kering sempurna
 - f. Tim bedah harus menggunakan alas kaki anti slip
 - g. Kaset harus tahan slip dan bila kaset tersaturasi oleh cairan, harus segera diganti.
 - h. Pastikan kabel-kabel tidak melintang di tengah jalan. Kabel harus dibundel sebaiknya di langit-langit jika memungkinkan
 - i. Alat-alat dan monitor harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga akses jalan tidak terhalang dan lantai dapat terlihat
 - j. Pencahayaan harus diatur dengan baik agar dapat melihat dengan jelas di dalam ruang operasi

9.2 Postoperative Care

- A. Mengkaji status mental pasien, dapat dilakukan dengan menanyakan kepada pasien:
 1. Tanggal hari ini
 2. Hari apa hari ini
 3. Nama tempat ia berada saat ini
 4. Nomor teleponnya
 5. Nama jalan tempat tinggalnya
 6. Berapa umurnya
 7. Kapan ia dilahirkan
 8. Siapa nama gadis ibu kandungnya
 9. Berapa hasil 20 dikurang 3, lalu hasilnya dikurang 3 lagi, dst sampai beberapa kali
- B. Mengkaji status fisik pasien, dapat dilakukan dengan memeriksa tanda vital, derajat nyeri, adanya pembengkakan, fungsi respirasi, *drainage* luka, efek samping anestesi, atau *deep vein thrombosis*
- C. Mengkaji obat-obatan yang dibutuhkan, hal ini meliputi obat-obatan apa yang harus diteruskan dari operasi, atau mana yang harus distop atau obat-obat baru, termasuk darah dan komponen-komponen darah yang diperlukan. Peresepan dan pemberian obat-obatan tersebut harus dicatat dengan baik sesuai urutannya, semua perintah verbal diulang kembali, dan dilabel secara benar. Dapat dipikirkan pemanfaatan teknologi komputer untuk pendokumentasian maupun pengingat.
- D. Mencegah infeksi (khususnya dari surgical site, kateter urin, dan akses intravena)
 1. Monitor ketat suhu tubuh dan kadar glukosa darah untuk mengurangi risiko infeksi *post operatif* dari *surgical site*
 2. Gunakan kateter urin hanya bila diperlukan
 3. Kurangi waktu penggunaan kateter urin, kateter harus sering diganti secara berkala
 4. Gunakan teknik yang benar untuk insersi dan perawatan
 5. Catat semua penggunaan kateter urin.

9.3 Proses Pemulangan Pasien.

Beberapa poin kunci dalam pemulangan pasien:

1. Komunikasi sedini mungkin dan sesering mungkin dengan pasien
2. Koordinasi proses pemulangan (bukan hanya di hari terakhir, tetapi selama perawatan di rumah sakit)
3. Mengatur proses secara sistematis
4. Melibatkan pasien dalam proses perencanaan pemulangan
5. Edukasi pasien dan keluarganya
6. Berbagi sumber dengan pasien, misalnya tentang layanan rumah pemesanan makanan dan transportasi di komunitas
7. Membuat perjanjian dengan pasien dan keluarganya, bila memungkinkan, untuk *follow up*. Berikan catatan berisi nama, alamat, dan telepon yang bisa dihubungi
8. Rekonsiliasi pengobatan, lakukan *double-check* untuk obat-obatan terakhir yang diberikan untuk di rumah. Berikan kepada pasien daftar obat-obat yang akan ia konsumsi di rumah, daftar tersebut harus mencakup deskripsi obat, indikasi, dosis, jadwal pemberian, dan efek samping yang mungkin ditimbulkan. Hal ini bersama dengan pengertian pasien harus selalu direkonfirmasi oleh tenaga kesehatan. Pasien dianjurkan untuk selalu membawa daftar obatnya, termasuk ketika kontrol berobat
9. Kolaborasi dengan layanan komunitas
10. *Summary* pemulangan:
 - a. Diagnosis utama dan tambahan
 - b. Riwayat pengobatan yang temuan fisik yang menunjang
 - c. Tanggal operasi atau tindakan invasif dan perawatan
 - d. Prosedur yang dilakukan
 - e. Hasil prosedur dan hasil laboratorium yang dilakukan
 - f. Rekomendasi konsultan subspesialis
 - g. Informasi yang diberikan kepada pasien dan keluarganya
 - h. Kondisi pasien dan status fungsional saat pemulangan
 - i. Obat-obat yang diberikan setelah pulang
 - j. Alasan penggantian obat
 - k. Janji untuk *follow up*
 - l. Hasil tes yang masih menunggu saat pemulangan
 - m. Detail mengenai rencana *follow up*
 - n. Nama dan kontak dokter bedah yang bertanggung jawab

BAB X

PRINSIP PELAYANAN BEDAH

10.1 Kesimpulan

1. Tim bedah mengoperasi pasien yang benar pada lokasi tubuh (situs) yang tepat.
2. Tim bedah menggunakan cara-cara yang tepat untuk mencegah hal-hal yang membahayakan yang diakibatkan penggunaan anestesi dalam melindungi pasien dari nyeri.
3. Tim bedah mengenali dan siap secara efektif menangani terhadap keadaan-keadaan jalan napas atau fungsi respirasi yang mengancam nyawa
4. Tim bedah mengenali dan siap secara efektif menangani risiko pasien kehilangan darah *massif*.
5. Tim bedah menghindari mencetuskan reaksi alergi atau efek samping obat di mana pasien telah diketahui memiliki risiko.
6. Tim bedah secara konsisten menggunakan cara-cara yang tepat untuk meminimalisasi risiko infeksi di lokasi / lapangan operasi.
7. Tim bedah mencegah ketidaksengajaan meninggalkan kassa atau instrumen bedah di dalam luka operasi.
8. Tim bedah mengamankan dan mengidentifikasi secara akurat semua spesimen bedah.
9. Tim bedah mengkomunikasikan secara efektif segala informasi penting yang diperlukan demi keamanan penanganan operasi.
10. Rumah sakit dan sistem kesehatan menetapkan *surveilans* rutin tentang *surgical capacity, volume, dan results*.

10.2 Prinsip Pertama

1. Mengidentifikasi pasien dengan pasien sendiri (atau *caregiver*), label dan *informed consent* (tidak hanya nama, tetapi juga tanggal lahir, alamat, dan nomer induk pasien), bagian (sisi) tubuh yang akan dioperasi, dan mengecek rekam medis pasien dan hasil radiologi.
2. Identifikasi dilakukan ketika prosedur akan dijadwalkan, ketika perawatan pasien dipindahtangankan / ditransfer, sebelum pasien memasuki kamar operasi / tindakan, dan sebelum dilakukan induksi anestesi.
3. Menandai bagian tubuh (sisi) yang akan dioperasi.
 - a. Penandaan harus dilakukan oleh dokter bedah atau diwakilkan oleh orang yang pasti hadir dalam ruang operasi saat insisi.
 - b. Penandaan harus dilakukan saat pasien sadar agar pasien bisa dilibatkan untuk konfirmasi atau jika tidak memungkinkan dapat diwakilkan oleh *caregiver*.
 - c. Penandaan harus jelas dengan spidol / penanda permanen, bisa dengan anak panah dengan ujung mengarah pada lingkaran yang akan dioperasi.
 - d. Melakukan *time-out* atau *surgical pause* sesaat sebelum insisi
 - a. Dokter bedah menyatakan dengan jelas nama pasien, jenis operasi yang akan dilakukan, dan sisi lokasi yang akan dioperasi.
 - b. Perawat dan penata / dokter anestesi harus mengkonfirmasi bahwa informasi yang dinyatakan benar.

10.3 Prinsip Kedua

1. Penata / dokter anestesi mengecek kelengkapan peralatan anestesi yang meliputi:
 - a. Mesin atau apparatus yang mensuplai gas, uap, anestesi lokal, atau intravena untuk menginduksi maupun mempertahankan anestesi
 - b. Alat-alat yang diperlukan untuk patensi jalan napas
 - c. Mesin monitor yang diperlukan untuk evaluasi kontinyu pasien

2. Pengecekan ini dilakukan setiap harinya di awal hari operasi, sebelum melakukan setiap tindakan anestesi, dan setelah setiap adanya perbaikan atau pemeliharaan, atau setiap pembelian alat baru.
3. Penata/ dokter anestesi memastikan oksimeter denyut sudah terpasang dengan baik pada pasien.
4. Penyediaan suplai dan pemeliharaan mesin, perlengkapan anestesi, dan obat-obatan anestesi adalah tanggung jawab pihak manajemen rumah sakit.
5. Penata / dokter anestesi dipastikan sudah mengisi *surgical safety checklist*.

10.4 Prinsip Ketiga

1. Semua pasien harus dievaluasi jalan napasnya sebelum induksi anestesi, untuk menilai potensial bahaya.
2. Penata / dokter anestesi harus memiliki strategi penanganan jalan napas dansiap melakukannya pada saat-saat yang diperlukan.
3. Apabila ditemukan kasus sulit jalan napas, harus tersedia asisten (atau orang kedua) untuk segera membantu dan harus selalu ada rencana *back up*, seperti anestesi regional atau intubasi sadar di bawah pengaruh anestesi lokal.
4. Seluruh penata / dokter anestesi harus terus mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya dalam hal tata laksana jalan napas, terutama untuk kasus-kasus sulit.
5. Setelah intubasi, penata / dokter anestesi harus selalu mengecek penempatan ETT dengan mendengarkan suara napas yang simetris dan ventilasi lambung, serta memantau oksigenasi pasien dengan oksimeter denyut.
6. Pasien yang akan menjalani operasi elektif harus dipuasakan dan untuk pasien yang berisiko aspirasi harus diberikan obat untuk mengurangi sekresi lambung dan meningkatkan pH.

10.5 Prinsip Keempat

1. Sebelum induksi anestesi, penata / dokter anestesi harus mempertimbangkan kemungkinan kehilangan darah *masif* dan bila hal itu termasuk berisiko, harus dipersiapkan secara matang. Bila risiko tidak diketahui, penata/ dokter anestesi harus mengkomunikasikan hal ini dengan dokter bedah sehubungan dengan kemungkinan terjadinya.
2. Sebelum insisi kulit, tim bedah harus mendiskusikan tentang risiko kehilangan darah *masif* ini dan memastikan akses intravena yang adekuat untuk mengatasinya.
3. Seorang anggota dari tim bedah sebaiknya mengkonfirmasi ketersediaan darah jika sewaktu-waktu diperlukan selama operasi berlangsung

10.6 Prinsip Kelima

1. Penata / dokter anestesi harus sepenuhnya memahami farmakologi obat-obatan yang ia berikan, termasuk toksisitasnya.
2. Setiap pasien yang akan diberikan obat, sebelumnya harus diidentifikasi secara jelas dan eksplisit oleh orang yang akan memberikan obat.
3. Identifikasi meliputi riwayat penggunaan obat yang jelas, informasi mengenai alergi dan reaksi hipersensitivitas lainnya.
4. Obat-obatan harus berlabel (mencakup nama obat, konsentrasi, tanggal kadaluwarsa) dan harus diperiksa kesesuaiannya dengan dicek ulang sebelum pemberian, terlebih yang akan dimasukkan ke dalam jarum suntik.
5. Sebelum setiap pemberian obat, harus dikomunikasikan agar terjadi kesesuaian pemahaman mengenai indikasi, kontra indikasi, dan informasi lainnya yang relevan.
6. Harus dipastikan tidak ada kesalahan pemberian obat baik karena tertukar atau nama yang mirip atau kemasan yang serupa. Obat-obatan yang berbahaya sebaiknya dipisahkan tempat penyimpanannya dan disusun secara sistematis.

7. Setiap kesalahan pemberian obat yang terjadi selama anestesi harus dilaporkan dan dibahas.

10.7 Prinsip Keenam

1. Antibiotik profilaksis harus diberikan secara rutin pada kasus bedah yang memiliki kemungkinan terkontaminasi dan dipertimbangkan pada kasus bedah tanpa kontaminasi. Pemberian antibiotik profilaksis dalam kurun waktu 1 jam sebelum insisi dilakukan dan diberikan dalam dosis yang sesuai untuk patogen yang biasa mengkontaminasi prosedur tersebut.
2. Sebelum insisi kulit, tim bedah harus mengkonfirmasi pemberian antibiotic profilaksis tersebut sudah dilakukan pada 1 jam sebelumnya. Untuk pemberian vancomycin, infus harus sudah selesai / rampung sekurang kurangnya 1 jam sebelum insisi dilakukan.
3. Harus ada sistem sterilisasi rutin untuk semua peralatan bedah dengan indikator yang dapat diperiksa sebelum alat-alat diletakkan pada tempat-tempat steril.
4. Sebelum dilakukan induksi anestesi, perawat yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat alat-alat bedah harus mengkonfirmasi sterilitas alat-alat dengan mengevaluasi indikator dan harus memberitahukan kepada dokter bedah dan penata / dokter anestesi bila terjadi masalah.
5. Pemberian dosis ulang antibiotik profilaksis harus dipertimbangkan bila prosedur bedah memerlukan waktu lebih dari 4 jam atau jika ada bukti perdarahan *masif intraoperatif*. Bila digunakan vancomycin, tidak diperlukan pemberian dosis ulang kecuali prosedur bedah memerlukan waktu lebih dari 10 jam.
6. Antibiotik profilaksis harus distop dalam 24 jam setelah operasi.
7. Rambut tidak harus dipotong kecuali akan mengganggu tindakan operasi. Bila diperlukan, pemotongan harus dilakukan dalam waktu 2 jam sebelum operasi. Pencukuran tidak dianjurkan karena meningkatkan risiko infeksi.
8. Pasien bedah harus mendapatkan oksigen *perioperasi* sesuai kebutuhan masing-masing.
9. Suhu inti tubuh harus dipantau dan dipertahankan normotermia selama perioperative.
10. Seluruh kulit pasien yang akan dioperasi harus dipersiapkan dengan antiseptik yang sesuai sebelum operasi. Agen antimikroba harus dipilih berdasarkan kemampuannya menurunkan jumlah mikroba pada kulit dengan cepat dan kemanjurannya selama operasi.
11. Antiseptik tangan pembedah harus menggunakan sabun antiseptik. Tangan dan lengan harus digosok 2-5 menit. Bila tangan sudah bersih, dapat menggunakan alkohol untuk antiseptik.
12. Tim bedah harus menutup rambut dan memakai gaun steril dan sarung tangan steril *impermeabel*, dan masker selama operasi.
13. Rokok sebaiknya distop setidaknya 30 hari sebelum operasi elektif bila memungkinkan.
14. Penutup steril setelah pembedahan harus dipertahankan di atas luka operasi 24-48 jam.
15. Harus dilakukan *surveilans* aktif untuk infeksi oleh tenaga kontrol infeksi terlatih. Informasi yang diperoleh harus dilaporkan kepada dokter bedah dan administrasi yang bersangkutan.
16. Perlu dipertahankan aliran udara bertekanan positif di dalam kamar operasi.
17. Kamar operasi harus dibersihkan dengan seksama setelah kasus-kasus infeksi atau operasi yang kotor dan setiap akhir hari operasi.
18. Perlu dilakukan penyuluhan mengenai kontrol dan pencegahan infeksi setidaknya setahun sekali.

10.8 Prinsip Ketujuh

1. Setelah operasi selesai, dokter bedah harus melakukan *eksplorasi* alat secara berurutan sebelum menutup kavitas atau lapang operasi.
2. Pada awal dan akhir operasi dilakukan penghitungan lengkap (*full count*) kassa, alat-alat tajam, instrumen (plester, klip, dan lain-lain), terutama bila operasi melibatkan *kavitas peritoneal*, *retroperitoneal*, pelvis, dan toraks.
3. Penghitungan dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang perawat yang sama, atau dengan alat penghitung otomatis (jika ada)
4. Sebelum penghitungan selesai, tidak boleh mengeluarkan alat dari dalam kamar operasi, meskipun ada alat yang terjatuh ke lantai
5. Bila karena satu dan lain hal penghitungan terputus, mulai lagi penghitungan dari awal.
6. Idealnya hasil penghitungan dicatat dan disertakan dalam status pasien, dapat juga dilakukan penghitungan menggunakan *whiteboard*, tetapi hasilnya tetap harus dicantumkan di dalam status pasien.
7. Kassa dipak per 5 atau 10. Pak yang ternyata ditemukan tidak sesuai harus ditandai, dipak ulang, dipindahkan dari lapang steril, dan dipisahkan dari kassa lain.
8. Jarum jahit dihitung berdasarkan jumlah yang tertera pada kemasan dan harus diverifikasi. Tidak boleh meletakkan jarum dalam keadaan bebas diatas meja, jarum harus selalu berada pada alat pemegang jarum (*needleholder*) atau di dalam kemasannya, atau di tempat jarum / *container*
9. Semua alat harus dihitung per jenis itemnya. Demikian pula bila ada alat yang rusak. Bila terjadi miskal kulasi, alat yang hilang harus dicari (misalnya di lantai, tong sampah, kain, tubuh pasien, sekitar pasien, meja operasi, dan lain-lain)
10. Bila alat yang hilang masih tidak dapat ditemukan, lakukan *X-ray*. Demikian pula bila terjadi kelupaan menghitung, harus dilakukan *X-ray*
11. Alasan tidak dilakukan penghitungan dan hasil *X-ray* harus disertakan distatus pasien
12. Dipertimbangkan penggunaan alat-alat operasi yang bisa terdeteksi *X-ray* (misalnya dengan barcode atau radio-label).

10.9 Prinsip Kedelapan

1. Tim bedah harus mengkonfirmasi bahwa semua spesimen bedah dilabel dengan benar dengan mencantumkan identitas pasien, nama specimen dan lokasi asal diambilnya.
2. Hal tersebut harus dibacakan dengan jelas oleh salah seorang anggota tim bedah dan satu orang lainnya mengkonfirmasi / menyetujui.

10.10 Prinsip Kesembilan

1. Sebelum insisi kulit, dokter bedah, perawat, dan penata / dokter anestesi harus menginformasikan hal-hal khusus atau penting yang berbeda dari operasi biasa, seperti risiko kehilangan darah masif, alat-alat khusus yang akan digunakan, dan komorbiditas lainnya.
2. Untuk kasus-kasus tertentu di mana pencitraan radiologi dibutuhkan, tim bedah harus memastikan peralatan siap sedia.
3. Sebelum pasien meninggalkan ruang bedah, dokter bedah harus menginformasikan anggota tim lainnya mengenai alterasi yang dilakukan masalah yang mungkin terjadi pada periode *post operatif* dan rencana penatalaksanaannya.
4. Penata / dokter anestesi harus menyimpulkan keadaan klinis pasien selama operasi dan memberitahukan instruksi untuk tata laksana pasien selanjutnya

-
5. Harus dibuat laporan pembedahan dengan sekurang-kurangnya dokter bedah mencantumkan nama prosedur (utama dan tambahan), nama asisten, detail prosedur, dan kehilangan darah *intraoperatif*; dokter anestesi mencantumkan tanda-tanda vital *intraoperatif*, obat dan cairan yang dimasukkan, dan kejadian instabilitas (bila ada); perawat mencantumkan penghitungan alat / instrumen, nama penghitung, alat-alat / kassa yang sengaja ditinggalkan di dalam tubuh pasien, dan alasan bila tidak dilakukan penghitungan.
 6. Rekam medis pasien harus jelas mencantumkan nama dan nomer pasien disetiap halamannya, ditulis atau diketik lengkap dengan tanggal dan waktu, objektif atau sesuai dengan fakta, kontemporer atau dicatat sesegera mungkin tanpa ditunda, mudah dilacak, asli dan jika ada yang salah segera dikoreksi, setiap perubahan harus mencantumkan tanggal dan ditandatangani dan menyertakan catatan yang menjelaskan mengapa perubahan itu terjadi
 7. Sebaiknya dicantumkan pula seluruh nama anggota tim bedah

10.11 Prinsip Kesepuluh.

Untuk surveilans tingkat rumah sakit, harus mengumpulkan data secara sistematis mengenai angka mortalitas *day-of-surgery*, angka mortalitas *inhospital postoperatif*, angka infeksi di situs operasi (*surgical site*), dan *surgical apgar score*.

BAB XI DOKUMENTASI

Dalam pelaksanaannya pembuatan laporan operasi didokumentasikan dalam lembar laporan operasi maupun ERM Laporan Operasi.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 4 Agustus 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

